

SÍNDROME DEPRESIVO

C.M. Franch Pato, V. Ámez Cepeda, R. Gómez Martínez.

INTRODUCCIÓN

Los síntomas depresivos constituyen unos de los motivos más frecuentes de consulta en la urgencia, bien como primera consulta, bien como recaídas o para ajuste de medicación. La queja del paciente puede ser directamente el ánimo depresivo o pensamientos/actos autolíticos, o presentarse con sintomatología depresiva enmascarada por somatizaciones o alteraciones conductuales.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico principal de un síndrome depresivo en el Servicio de Urgencias se hace a través de una anamnesis detallada, existiendo tres síntomas fundamentales en los trastornos depresivos:

- Ánimo decaído
- Anhedonía: incapacidad para disfrutar de las actividades que normalmente nos son placenteras
- Anergia: falta de energía

Además, pueden existir otra serie de síntomas como son:

- Alteraciones en ritmos biológicos (apetito/sueño)
- Alteraciones en esfera sexual
- Alteraciones conductuales
- Quejas somáticas
- Quejas cognitivas

Es importante recoger, además de la sintomatología actual, la historia anterior y el curso longitudinal del trastorno afectivo, así como los tratamientos previos y la respuesta y tolerancia a ellos y la presencia de factores precipitantes del episodio actual.

En la exploración se deberán valorar, además, las cogniciones en torno a la muerte, debiendo distinguir entre los deseos de morir o estar muerto de la ideación propiamente autolítica, de mayor gravedad aún si incluso ha llegado a planificar su propia muerte.

Diagnóstico diferencial

Es importante descartar los trastornos orgánicos en pacientes que refieren sintomatología depresiva de reciente aparición, ya que algunos de los síntomas propios de la depresión (anergia, anorexia, pérdida de peso, astenia) pueden deberse a enfermedades orgánicas, como por ejemplo las que se muestran en la siguiente tabla:

Sustancias Psicoactivas	Anfetaminas y simpaticomiméticos relacionados Alucinógenos
Medicaciones	Corticoesteroides Levodopa Antihipertensivos de acción central Cicloserina Estrógenos Clomifeno
Trastornos Endocrinos	Hipotiroidismo, hipertiroidismo Enfermedad de Addison Síndrome de Cushing Hipoglucemia, Diabetes Mellitus Hiperparatiroidismo Hipopituitarismo
Otros Trastornos Sistémicos	Anemia perniciosa Insuficiencia hepática Insuficiencia renal Artritis reumatoide Lupus eritematoso sistémico Neoplasias (especialmente ca. páncreas, síndrome carcinoide) Infecciones víricas (gripe, neumonía, mononucleosis, hepatitis)
Causas Intracraneales	Tumores cerebrales TCE Enfermedad de Parkinson Infecciones (neurosífilis) Procesos demenciales incipientes

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una vez realizado el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico diferencial se plantea la cuestión de iniciar o no un tratamiento antidepressivo en el Servicio de Urgencias.

Si el paciente presenta una depresión moderada-leve, será valorado en un plazo breve por otro profesional, que se hará cargo de su tratamiento continuado, por lo que si no disponemos datos de respuesta a tratamientos previos, lo más recomendable es no iniciar en ese momento un tratamiento antidepressivo y que sea su médico de atención primaria o psiquiatra de referencia quien lo inicie, pautando mientras tanto ansiolíticos en caso de que sea preciso.

Si existen antecedentes de buena respuesta en episodios anteriores a un antidepressivo, o en caso de que no pueda ser valorado en corto plazo por otro profesional, lo más adecuado será iniciar el tratamiento antidepressivo. La elección se hará en función de respuestas previas, tolerancias, interacciones farmacológicas, clínica del paciente, recomendando iniciar con un ISRS junto con un ansiolítico.

Si ya se encuentra tomando un antidepressivo, con buena tolerancia, pero respuesta insuficiente, puede aumentarse la dosis de este, dejando la decisión de cambio de antidepressivo o asociación de otro a su especialista habitual.

Si el paciente presenta sintomatología depresiva grave, deberá avisarse al especialista, ocurriendo esto en los siguientes casos:

- El principal criterio de ingreso de un paciente depresivo es el riesgo de suicidio, lo que hace necesaria la valoración por parte del especialista, debiendo explorarse sistemáticamente en todo paciente depresivo. Hay que preguntar por la presencia de deseos de muerte, ideación, planes o intentos autolíticos.
- Clínica depresiva mayor, con tristeza vital, arreactividad, empeoramiento matutino, anhedonia total, inhibición o agitación psicomotriz intensa
- La presencia de ideas delirantes, tanto congruentes (culpa, ruina) como incongruentes con el estado del ánimo
- Las dudas diagnósticas
- La resistencia al tratamiento
- La existencia previa de un diagnóstico de Trastorno Bipolar

Valoración del riesgo de suicidio

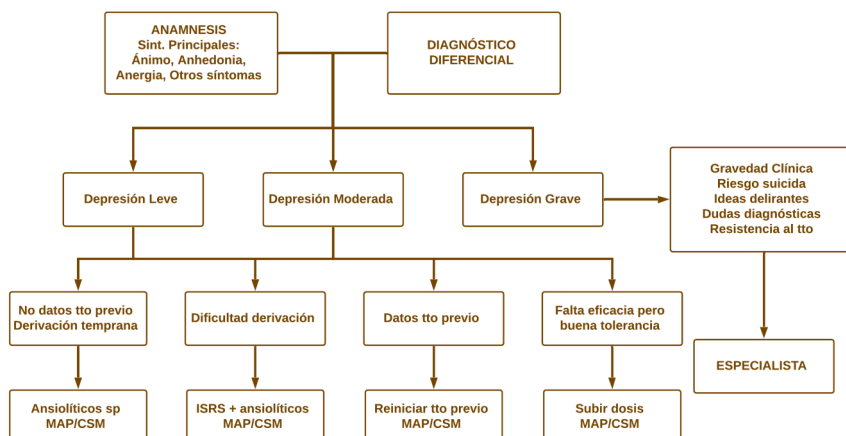
Existen varias escalas, una de las mas prácticas es la escala de **SAD PERSONS**.

ÍTEMS	SI	NO
• S: Sexo masculino		
• A: Edad < 20 o > 45 años		
• D: Depresión		
• P: Previous attempt (intentos previos de suicidio)		
• E: Ethanol abuse (abuso de alcohol)		
• R: Rational thinking loss (psicosis o trastornos cognitivos)		
• S: Social supports lacking (sin apoyo social)		
• O: Organized plan (plan organizado de suicidio)		
• N: No spouse (sin pareja estable)		
• S: Sickness (enfermedad somática)		

Cada ítem da una puntuación de uno, siendo 10 su máxima puntuación.

- **0-2 puntos:** sin riesgo. Alta con seguimiento ambulatorio.
- **3-4 puntos:** bajo riesgo. Seguimiento ambulatorio intenso, considerar ingresar
- **5-6 puntos:** riesgo medio. Si no hay apoyo familiar estrecho debe ingresar
- **7-10 puntos:** riesgo alto. Ingreso. Riesgo de intento inminente.

Algoritmo de Actuación



BIBLIOGRAFÍA

- Cebollada Gracia A., Blasco Fontecilla H. El paciente afectivo. En: Chinchilla A. Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson S.A.; 2003. p. 191-219
- Síntomas y síndromes psiquiátricos presentados como urgencias. En: Puri B.K, Treasaden I.H. Urgencias de psiquiatría. Madrid: Grupo Aula Médica S.L.; 2009. p. 51-66

CRISIS DE ANSIEDAD - ATAQUE DE PÁNICO

V. Ámez Cepeda, R. Gómez Martínez, C.M. Franch Pato.

INTRODUCCIÓN

Ansiedad normal: La ansiedad nos pone en alerta y nos ayuda a afrontar amenazas, es normal experimentar ansiedad, a menudo se acompaña de una sensación desagradable y vaga, un malestar que puede estar acompañado de síntomas vegetativos (en mayor o menor grado) y de inquietud. Esto es adaptativo cuando nos ayuda a afrontar situaciones.

Ansiedad patológica: Cuando la ansiedad deja de ser útil para transformarse en un impedimento para llevar a cabo la vida cotidiana.

Ansiedad y urgencias: No podemos banalizar la ansiedad ya sea por su alta prevalencia en el servicio de urgencias y por la incapacidad que provoca, como por la trascendencia de enfermedades somáticas que pueden subyacer a un cuadro de ansiedad.

Según las tasas de prevalencia en la población general, hasta el 11,8% presentan algún trastorno de ansiedad en un año y otro 11% refieren manifestaciones de ansiedad asociadas a enfermedades físicas.

Actitud:

- Descartar patología orgánica que justifique el cuadro de ansiedad.
- Pautar tratamiento adecuado y derivar al especialista correspondiente.

DIAGNÓSTICO

Signos y síntomas de ansiedad:

Síntomas y signos físicos	Síntomas psíquicos	
• Temblores • Sudoración • Rubor, palidez • Taquicardia • Palpitaciones • Sensación disneica • Hiperventilación forzada • Dolor precordial	• Malestar abdominal, náuseas, diarrea • Vértigo, mareo, desvanecimiento • Parestesias • Midriasis • HTA • Hiperreflexia • Dificultad para tragar	• Sensación de desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo) • Sensación de muerte inminente • Sensación de inestabilidad • Miedo a perder el control, a volverse loco

Diagnóstico diferencial

- Miedo o angustia como reacción psíquica a cualquier malestar físico o tratamiento doloroso.
- Trastornos orgánicos:

Enfermedades cardiovasculares	Enfermedades Neurológicas
Anemia Angina, IAM ICC HTA Hiperreactividad beta-adrenérgica Prolapso válvula mitral Taquicardia auricular paradójica	Neoplasias intracraneales TCE Síndrome posconfusional Hemorragia subaracnoidea Encefalitis Epilepsia Enfermedad cerebrovascular Migraña Esclerosis múltiple Corea de Huntington Enfermedad de Wilson
Enfermedades Pulmonares	
Asma Hiperventilación TEP	
Enfermedades endocrinas	Otras enfermedades
Hipo/ hipertiroidismo Hipo/ hiperglucemia Hipoparatiroidismo Síndrome carcinoide Enfermedad de Addison Síndrome de Cushing Feocromocitoma Trastorno menopáusico Síndrome premenstrual	Trastornos electrolíticos Infecciones sistémicas Uremia Déficit de vitamina B12 Hipoxia Intoxicación por metales pesados Lupus eritematoso sistémico Artritis reumatoide Arteritis de la temporal Poliarteritis nodosa

- Abuso de drogas o abstinencia:

Intoxicación por fármacos y sustancias	Abstinencia de fármacos y sustancias		
Anfetaminas Alucinógenos Cocaína Marihuana	Nicotina Anticolinérgicos Teofilina	Alcohol Opiáceos Cafeína	Hipnótico- sedantes Antihipertensivos

- Comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos.

Pruebas complementarias

En ocasiones es conveniente para realizar el diagnóstico diferencial:

Análítica sanguínea: hemograma con formula leucocitaria, bioquímica básica, coagulación, sistemático y sedimento de orina, tóxicos en orina, ECG, Rx

tórax.

TRATAMIENTO

- Tranquilizar al paciente:
 - Indicarle que las pruebas complementarias han sido normales.
 - No decirle que no le pasa nada porque sí le pasa.
 - Explicarle lo que le está ocurriendo y la interpretación errónea que está realizando de sus síntomas neurovegetativos.
- Si hay hiperventilación: se le propone respirar dentro de una bolsa de plástico para evitar una crisis de tetania.
- **Psicofármacos:** El tratamiento de elección son Benzodiacepinas por vía oral. Es conveniente usar Bzd de acción rápida y vida media corta: Lorazepam, alprazolam, diazepam, clonazepam.

La vía de administración será oral o sublingual.

Evitar la vía intramuscular porque su absorción es errática.

- Lorazepam: 1 mg (1-5 mg). Dosis máxima diaria: 7.5 mg.
- Diazepam: 10 mg (5-20 mg). Dosis máxima diaria: 30 mg.
- Alprazolam: 0.5 mg (0.5-2 mg). Dosis máxima diaria: 6 mg
- Clonazepam: 0.5 mg (0.5-2mg). Dosis máxima diaria: 6 mg.

Se puede repetir a los 30 min si no se ha resuelto la crisis.

Trastorno de ansiedad /trastorno de pánico

En caso de crisis de ansiedad/ ataques de pánico de repetición, podemos hablar de un trastorno de pánico: los ataques son imprevistos y recurrentes, producen preocupación continua y el paciente tiene dificultades para mantener su vida habitual. En este caso estaría indicado pautar un tratamiento a largo plazo:

Los fármacos de primera elección son los ISRS (citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina, sertralina y fluvoxamina) siendo conveniente asociar una BZD durante 2-3 semanas y retirarla progresivamente.

ALERTA

- Cuidado con prolongar un tratamiento con BZD ya que producen habituación y tolerancia y es complicada su retirada.

Derivación:

- MAP
- Psiquiatra CSM:
 - Pacientes con síntomas resistentes pese al tratamiento.
 - Presencia de agorafobia o de otros trastornos fóbicos.
 - Sospecha de trastorno obsesivo-compulsivo.
 - Presencia de otros trastornos psiquiátricos comórbidos (depresión, abuso de tóxicos)
 - Ausencia de respuesta al tratamiento farmacológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Chinchilla A. Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson, 2010. P. 393-408.
- Kaplan HI. Trastornos de ansiedad. Sinopsis de Psiquiatría. 8ª ed. Madrid: médica Panamericana,1999; p. 657-710

PACIENTE PSICÓTICO EN URGENCIAS

S. Nuñez Sevillano, C.M. Franch Pato, V. Ámez Cepeda, R. Gómez Martínez.

-Mire vuestra merced -respondió Sancho- que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. —**Miguel de Cervantes**. Don Quijote de la Mancha.

La psicosis es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida significativa del contacto entre la realidad objetiva (externa y racional) del paciente y sus correspondientes representaciones mentales. Los componentes principales de la psicosis son los delirios, las alucinaciones y trastornos en la forma del pensamiento y de la conducta.

En este capítulo se pretende describir un protocolo de estudio y actuación frente al paciente con sintomatología psicótica que pueda acudir al Servicio de Urgencias.

SEMIOLOGÍA DE LA PSICOSIS

Los síntomas más característicos de la psicosis son los siguientes:

Los **delirios** se describen como alteraciones del contenido del pensamiento que deben cumplir las siguientes características:

- Son erróneas.
- Se mantienen irrefutables ante cualquier argumentación basada en la lógica.
- Se establecen por una vía patológica.
- Se consideran primarias, puesto que no dependen de otra alteración psicopatológica, en este caso se trataría de ideas deliroides.

El contenido más habitual del pensamiento en pacientes con esquizofrenia **suele ser de tipo persecutorio**, que suele mostrarse en forma de elevada suspicacia, aunque en ocasiones pueden apreciarse tintes megalomaniacos. La vivencia de estos pensamientos suele acompañarse de angustia intensa que puede ocasionar, incluso, bloqueos del pensamiento.

Las **alucinaciones** son otra manifestación clínica principal de la clínica psicótica. Se definen como alteraciones de la sensopercepción en las que no hay objeto real ni estímulo alguno en el mundo exterior. Deben cumplir las siguientes características:

- No dependen de la voluntad del paciente que las padece.
- Son escasamente o nada modificables por la sugestión.
- El paciente se encuentra en un estado de realidad alterado.

En cuanto a los tipos de alucinaciones, podemos encontrar alteraciones de cualquiera de los sentidos. Mientras que en los pacientes con esquizofrenia **es habitual que se presenten alucinaciones auditivas**, en forma de voces, ruidos o susurros, con gran repercusión afectiva por las mismas, las alucinaciones visuales son infinitamente menos frecuentes en pacientes con esta patología. La presencia de **alucinaciones visuales debe hacernos sospechar hacia un posible origen orgánico** del cuadro, por lo que debemos iniciar un despistaje y valorar consumo de tóxicos.

MOTIVOS DE CONSULTA

El paciente puede ser derivado al Servicio de Urgencias ya sea **de forma voluntaria**, por el propio malestar que le generan los síntomas de su padecimiento, **o de forma involuntaria** a través de la solicitud de los familiares o el médico de área para valoración por los especialistas.

Los **motivos pueden variar** desde la clínica primordial de su enfermedad, como las alteraciones descritas en el apartado anterior, a alteraciones del estado de ánimo, alteraciones de los ritmos biológicos, inhibición psicomotriz, heteroagresividad, tentativas autolíticas o efectos secundarios de la medicación.

SÍNTOMAS ATRIBUIBLES A PSICOFÁRMACOS

Dentro de los posibles motivos de consulta del paciente psicótico, se encuentran efectos secundarios de la medicación como:

- **Acatisia:** se define como una inquietud interna que se expresa como la incapacidad para poder estar sentado, tumbado, o quieto. La angustia que provoca esta sintomatología puede provocar alteraciones conductuales. Está indicado disminuir la dosis de antipsicótico, si fuera posible, o el tratamiento sintomático basado en benzodiazepinas o betabloqueantes.
- **Distonias agudas:** se describen como alteraciones musculares en forma de contracción breve y sostenida que provoca posturas anormales en el paciente con repercusión y molestia para el mismo. Está indicado el uso de anticolinérgicos (5mg de biperideno) o benzodiazepinas (5-10mg de diazepam).
- **Parkinsonismo iatrogénico:** se caracteriza por bradicinesia, hipomimia, rigidez o sialorrea, evocando en su presentación a la Enfermedad de Parkinson. Está indicado disminuir la dosis o sustituir por otro antipsicótico menos incisivo, incluso puede coadyuvarse un tratamiento corrector anticolinérgico (biperideno).
- **Discinesias tardías:** se define como un cuadro motor que puede acontecer en pacientes con tratamientos crónicos de neurolepticos, especialmente clásicos y a dosis altas, caracterizado por movimientos anormales involuntarios. Habitualmente empeora tras la retirada brusca de la medicación y aumenta de intensidad tras el uso de fármacos anticolinérgicos.
- **Síndrome neuroleptico maligno:** se trata de una urgencia médica donde la vida del paciente está comprometida, con una mortalidad del 5% en la actualidad. Se caracteriza por **fluctuaciones / alteración del nivel de conciencia, rigidez muscular, hipertermia y alteración del sistema nervioso autónomo**, con una importante disfunción autonómica en forma de sudoración (diaforesis), taquipnea, taquicardia e inestabilidad de la tensión arterial. El cuadro suele ir acompañado de rabdomiólisis y leucocitosis, por lo que puede objetivarse un aumento de la CK en la bioquímica. Se trata de un cuadro que suele manejarse en unidades de cuidados intensivos y su manejo se basa en la suspensión del tratamiento (fármacos antagonistas de los receptores de dopamina) y la rápida instauración de hidratación y vigilancia de constantes vitales. El uso de relajantes musculares como el dantroleno o la bromocriptina está indicado en estas situaciones.

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN

En este momento es imprescindible conocer el motivo de la consulta del paciente, quién le acompaña y si existiera un estado de agitación en estos momentos.

Durante la entrevista, es necesaria la comprensión y la escucha activa, mostrando empatía por el paciente y en un entorno adecuado, prestando especial atención a la estimulación sensorial. Es de especial importancia acotar su narrativa al episodio actual que motiva la consulta en Urgencias, aunque puede ser relevante la cronología, antecedentes de situaciones similares y la presencia de desencadenantes.

DESCARTAR LA PRESENCIA DE PATOLOGÍA ORGÁNICA COMO ORIGEN DEL CUADRO.

Nos debe **hacer pensar en organicidad** la presencia de:

- Una sintomatología de inicio brusco.
- Sin periodo prodrómico.
- Alteración del nivel de conciencia.
- Antecedentes de consumo de tóxicos o signos compatibles con intoxicación/abstinencia de los mismos.
- Alteración en las constantes vitales.
- Antecedentes familiares o personales de patología con riesgo de sintomatología psicótica.
- Ausencia de antecedente psiquiátrico conocido.
- Otras características de **atipicidad** pueden ser una clínica fluctuante, una edad de presentación atípica, especialmente debuts en pacientes de edad avanzada, o la presencia, como ya hemos comentado, de alucinaciones visuales.

Si la clínica es compatible con alguna **etiología orgánica (tabla 1)**, tras estudio analítico y pruebas complementarias, deberá tratarse la enfermedad de base que la ocasiona. En caso de intoxicaciones deberán tomarse las medidas necesarias hasta la resolución de la misma, incluyendo su estancia en observación y el control sintomático de la agitación, con posterior valoración por parte de Psiquiatría si fuera necesario. En caso de psicosis secundaria a deterioros cognitivos o demencias puede ser necesario un ajuste de la medicación por parte de Psiquiatría para control sintomático una vez descartado un precipitante potencialmente tratable que explique la clínica.

Si la clínica es compatible con un **trastorno psiquiátrico**, tras un estudio analítico y pruebas complementarias que descarten organicidad, deberá consultar con el psiquiatra de guardia para valoración de tratamiento y actitud a seguir.

Como **criterios de ingreso**, se valorará si el paciente constituye una amenaza para sí mismo o terceros, la intensidad de la clínica y la angustia que ésta pueda generar, la presencia de un apoyo sociofamiliar o dificultades en el tratamiento, ya sea por dudosa adherencia, mala respuesta o necesidad de medidas terapéuticas no disponibles a nivel ambulatorio.

Tabla 1. Trastornos orgánicos en el diagnóstico diferencial de psicosis aguda.

- **Abuso de drogas:** alucinógenos, psicoestimulantes, cannabis y sus reacciones de angustia, alcohol con posible alucinosis o abstinencia a sustancias hipnóticas o sedantes.
- **Fármacos y sustancias tóxicas:** anticolinérgicos (en forma de fármacos, plantas o setas), glucocorticoides, toxicidad digital, agonistas dopaminérgicos (tratamiento en Parkinson), isoniacina, metales pesados o disulfuro carbónico.
- **Desequilibrios metabólicos:** hipoglucemias, encefalopatía hepática, porfiria aguda intermitente, Síndrome de Cushing, alteraciones del calcio o de la función tiroidea, pancreatitis o síndromes paraneoplásicos.
- **Deficiencias nutricionales:** insuficiencia de tiamina (vitamina B1) en el Síndrome de Wernicke-Korsakoff, insuficiencia de niacina (vitamina B3) en la pelagra o insuficiencia de vitamina B12.
- **Patología neurológica:** como las encefalitis, los abscesos cerebrales, las meningitis, la neurosífilis, el lupus, enfermedades como la de Wilson, Huntington o Alzheimer, sin olvidar la enfermedad cerebral vascular y las crisis epilépticas parciales complejas.

RESUMEN

- Realizar una anamnesis y exploración en un ambiente tranquilo y con escasa estimulación sensorial.
- Realizar un despistaje de probables causas orgánicas no solo a nivel analítico y de imagen, sino a través de sus antecedentes personales y familiares. Debemos recordar que una analítica de urgencia no descarta patología aguda.
- Prestar atención a signos de atipicidad a la hora de sospechar un origen psiquiátrico.
- Mantener en observación al paciente intoxicado hasta que la clínica propia del tóxico permita llevar a cabo una exploración psicopatológica, si fuera necesaria.

BIBLIOGRAFÍA

- Chinchilla A. Manual de Urgencias Psiquiátricas. Barcelona: Masson, 2003. p. 217-228. 581-585.
- Gastó C, Vallejo J. Manual de diagnóstico diferencial y tratamiento en Psiquiatría. Barcelona: Masson, 2001
- Kaplan HL, Sadock BJ. Manual de Psiquiatría de Urgencias. Madrid: Médica Panamericana, 1996

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN URGENCIAS

Antonio Serrano García

INTRODUCCIÓN

La agitación psicomotriz es un síndrome que se caracteriza por un marcado incremento de la actividad motora, generalmente se acompaña de:

- **Alteraciones afectivas** como la ansiedad, irritabilidad, euforia y otros
- **Alteraciones del pensamiento** como la desinhibición, incoherencia y otros.

La agitación psicomotriz es una circunstancia relativamente frecuente en los Servicios de Urgencias. Constituye un proceso que requiere atención inmediata puesto que se pone en riesgo tanto la seguridad del propio paciente como la del equipo sanitario que le atiende, debido a la conducta de este puede ser desproporcionada, impulsiva o negligente. Se debe de intentar diferenciar claramente la agitación de la violencia, debido a que la mayoría de los pacientes agitados no son violentos y la mayoría de las actitudes violentas no tienen una clínica/cuadro médico que las justifique. La agitación psicomotriz puede ser de causa: psiquiátrica, orgánica o mixta.

Agitación orgánica

La causa orgánica es lo primero que hay que descartar, supone un riesgo vital para el paciente, sospechamos de causa orgánica cuando el inicio del cuadro es agudo o subagudo en un paciente sin antecedentes psiquiátricos, con episodios fluctuantes, se caracteriza por alteración fluctuante del nivel de consciencia, inatención, desorientación temporoespacial, confusión mental y discurso incoherente. Debemos de diferenciarlo del delirium.

Las pruebas que debemos de realizar en urgencias para descartar organicidad son:

- **Hemograma, bioquímica, coagulación, sistemático y sedimento de orina con tóxicos en orina** (solicitar autorización verbal o escrita del paciente/familiar/acompañante y escribirla en HCL).
- **TAC craneal, Punción lumbar** si fiebre y/o clínica neurológica.

Las principales **causas orgánicas** de agitación orgánica son:

- **Tóxicas:** drogas, alcohol, fármacos (antiparkinsoniano, anticolinérgicos, digitálicos, corticoides, otros),
- **Metabólicas:** encefalopatía hepática, hipoglucemia, uremia, enfermedades endocrinas, hipoxia, hipercapnia, fiebre y alteraciones hidroelectrolíticas: hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia.
- **Neurológicas:** neoplasias, crisis epilépticas, infecciones del sistema nervioso, encefalopatía hipertensiva, ACV, TCE...

Agitación psiquiátrica

No existe alteraciones del nivel de consciencia, descartada la parte orgánica (examen físico y pruebas complementarias), se debe de buscar antecedentes de enfermedades psiquiátricas cuyas manifestaciones serán las propias de cada una desde: alucinaciones auditivas, alteración de la afectividad, ideación delirante, agresividad u hostilidad, alteraciones en el discurso...Las principales **causas de agitación psiquiátrica** son:

- **Trastornos afectivos:** episodio maníaco, episodio de depresión...
- **Trastornos psicóticos:** trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno delirante...
- **Otras causas:** crisis de ansiedad, trastorno de la personalidad, alteración de conducta en pacientes con discapacidad intelectual.

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico inicial

Independientemente del origen de la agitación es preciso constatar su existencia y controlarla con objeto de poder llevar a cabo con posterioridad un diagnóstico etiológico y un tratamiento adecuado.

Es preciso distinguir:

- **Agitación leve/moderada:** El paciente se muestra inquieto, nervioso, enfadado o demandante, pero es capaz de entablar una conversación y no se objetiva un riesgo de auto o heteroagresividad inmediato.
- **Agitación grave:** El paciente es incapaz por su estado mental de entablar una conversación o se observa riesgo de auto o heteroagresividad inmediato.

Diagnóstico etiológico

Son múltiples las causas que pueden motivar un estado de agitación en un paciente. Este diagnóstico etiológico sólo puede llevarse a cabo en casos de agitación leve/moderada o cuando la agitación grave haya sido controlada.

Posibles causas de agitación psicomotriz

- Delirium
- Consumo de sustancias
- Abstinencia de sustancias
- Disconformidad con el trato recibido
- Crisis de pánico
- Trastornos de Personalidad Límite/Antisocial
- Episodios psicóticos
- Agitación secundaria a enfermedad somática (encefalitis, IAM, hipoglucemia, demencia, etc...)
- Otras causas

Para realizar un diagnóstico etiológico debe realizarse una anamnesis y examen físico cuidadoso del paciente en la que se establezca si el cuadro de agitación responde a alguna motivación identificable (ambiental) o por el contrario responde a un proceso somático o psicopatológico. En la exploración debe incluirse la evaluación de la consciencia, la orientación, el contenido del pensamiento (ideación delirante), el curso del pensamiento, la sensorio-percepción (alucinaciones), el estado de ánimo (euforia, disforia) y el riesgo de auto o heteroagresividad.

Pruebas complementarias

- Constantes vitales: temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, glucemia.
- Hemograma, bioquímica, coagulación, sistemático y sedimento de orina con tóxicos.
- TAC Craneal
- Punción lumbar, si fiebre y/o clínica neurológica.
- Electrocardiograma.
- Alcoholemia si sospecha de ingesta de alcohol, solicitar autorización.

TRATAMIENTO

- Medidas generales: constantes vitales, glucemia, SatO₂.
- Seguridad del personal sanitario y de su entorno: familiares, acompañantes y del mismo paciente.
- Sujeción mecánica si fuera necesario, según protocolo del centro.
- Si no colabora: avisar a seguridad y/o fuerzas del orden: Policía local o nacional si fuera necesario.
- Sedación si persiste agresividad, usar fármacos: ver tabla

Lo primero que debe tenerse en cuenta ante un paciente agitado es asegurar la seguridad del personal sanitario que va a atenderle y de todas las personas que se encuentren en su entorno. De esta manera puede ser necesario solicitar la colaboración del personal de seguridad del centro o incluso, en casos extremos, de las fuerzas de orden público.

En casos de agitación grave puede ser necesaria la contención mecánica del paciente. Ésta deberá llevarse a cabo en todo caso por personal debidamente entrenado y bajo supervisión médica. Este tipo de contención requiere un protocolo estricto que debe estar desarrollado en cada centro sanitario, debe usarse sólo en caso de riesgo inmediato de auto o heteroagresividad, debe supervisarse de forma frecuente (cada 15 minutos por personal de enfermería y cada hora por personal médico) y no debe prolongarse más allá de lo estrictamente necesario. En caso de contención prolongada (más de 24 horas) se recomienda administrar al paciente heparina subcutánea para minimizar el riesgo de tromboembolismo.

Puede ser necesario administrar fármacos para controlar la agitación. En muchos casos no ha sido posible establecer en el momento de su administración un diagnóstico etiológico. En la tabla se dan algunas pautas en base a diagnósticos de sospecha o a circunstancias clínicas. Una vez controlada la agitación inicial debe procederse a realizar un diagnóstico etiológico preciso.

Fármacos en la agitación psicomotriz

SOSPECHA CLÍNICA	PAUTA DE AGITACIÓN
Paciente mayor de 65 años	• Haloperidol 1/2 ampolla IM. Repetir en 30 min si no cede, máximo 20mg/día. (Contraindicadas benzodicepinas).
Intoxicación etílica	• Tiapride 1 ampolla IM. Valorar añadir Diazepam (10 mg IM).
Abstinencia de opiáceos	• Clorazepato 20 mg IM. Valorar repetir en 30 minutos.
Crisis de pánico	• Lorazepam 1 mg sublingual. Repetir en 20 minutos si no cede. Si persiste o hay riesgo de tetania por alcalosis respiratoria usar Diazepam 10 mg IV.
Agitación secundaria a enfermedad médica	• Tratamiento etiológico de la causa. Si agitación severa Haloperidol ½ ampolla IM. Repetir en 30 min si precisa.
Agitación por episodio psicótico	• Haloperidol 1 ampolla IM + Clorazepato 50 mg IM (si hay angustia severa). • Haloperidol 1 ampolla IM + Levomepromacina 1 ampolla IM (si existe clínica psicótica intensa).
Trastorno de la personalidad	• Olanzapina (Zyprexa amp 10mg) 1 ampolla IM.
Disconformidad con el trato recibido o ansiedad leve	• Técnicas de tranquilización de verbal. Si persiste o progresa puede ofrecerse lorazepam 1 mg sublingual.

IMPORTANTE

- Ante un paciente agitado lo primero es asegurar la propia seguridad

BIBLIOGRAFÍA

- Juan Manuel Téllez Lapeira (último), Alejandro Villena Ferrer, Susana Morena Rayo, Pablo Pascual Pascual, Carmen López García. Guía clínica de El paciente agitado. Disponible en: <http://www.fisterra.com/guias-clinicas/el-paciente-agitado/>
- https://www.fundacionmanantial.org/ssm_area_3/programas/guias/guia_contencion.pdf
- <http://www.cfnavarra.es/salud/PUBLICACIONES/Libro%20electronico%20de%20temas%20de%20Urgencia/17.Psiquiatricas/El%20paciente%20agitado.pdf>

ESQUIZOFRENIA Y TRASTORNOS PSICÓTICOS

Antonio Serrano García

INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia es una enfermedad del Sistema Nervioso que se engloba en el grupo más amplio de los Trastornos Psicóticos, que se caracterizan por una pérdida de contacto con la realidad.

En los Servicios de Urgencias el objetivo principal consiste en identificar la presencia de este grupo de trastornos y solicitar la valoración de un especialista en Psiquiatría. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los pacientes con este grupo de trastornos presentan una elevada prevalencia de alteraciones endocrino-metabólicas y que la presencia de un trastorno psicótico no excluye la presencia de patología somática, siendo frecuente la existencia de psicosis secundarias.

DIAGNÓSTICO

El primer paso de cara al manejo de este grupo de pacientes en los Servicios de Urgencias consiste en asegurar su permanencia en el Hospital hasta que su evaluación haya sido completada, ya que la conciencia de enfermedad suele ser deficitaria y frecuentemente acuden a Urgencias por otros motivos. Puede ser necesario que el paciente sea supervisado de forma continua hasta que se complete su evaluación. No es conveniente hacer creer a los pacientes que se investiga un cuadro somático cuando se sospecha una alteración psiquiátrica puesto que, si bien puede facilitar el manejo inicialmente, disminuirá la posibilidad de que el paciente vuelva a solicitar ayuda para su proceso si se siente engañado y eso causará un innegable quebranto en el paciente.

Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia se encuentran recogidos en la CIE-10. Ante la presencia en la anamnesis de alucinaciones o ideas delirantes debe realizarse una cuidadosa exploración de la conciencia, la orientación, el curso del pensamiento y la esfera instinto-vegetativa, así como una amplia revisión de los antecedentes físicos y psíquicos del paciente.

En caso de que no existan antecedentes de cuadros psicóticos en el paciente o exista un cambio importante en la evolución de un cuadro de psicosis conocido previo, debe descartarse la presencia de una psicosis secundaria por lo que se recomienda la realización de las siguientes determinaciones:

- Tensión Arterial
- Temperatura
- Frecuencia cardíaca
- Tóxicos en orina
- Alcoholemia
- Hemograma
- Bioquímica
- Sistemático de orina
- TAC craneal (en mayores de 40 años)

Algunas causas de psicosis secundarias, sin pretender ser exhaustivos, podemos encontrarlas en:

- Consumo y/o abstinencia de alcohol y/o drogas
- Enfermedades neurológicas, como el Parkinson (ocasionalmente como efecto secundario de fármacos dopaminérgicos) y la Corea de Huntington
- Tumores o quistes cerebrales
- Demencias
- VIH y otras infecciones que afecten el cerebro
- Como efecto secundario de algunos fármacos como esteroides y estimulantes
- Algunos tipos de epilepsia
- Accidente cerebrovascular
- Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico
- Alteraciones hormonales
- Postparto
- Enfermedades autoinmunes que afecten al SNC

Una vez descartada la psicosis secundaria es preciso solicitar consulta al especialista en Psiquiatría que decidirá el abordaje más indicado.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Las psicosis primarias deben ser abordadas por un especialista, puesto que el abordaje farmacológico de forma aislada suele ser insuficiente para el control del cuadro y es preciso planificar los cuidados a largo plazo.

En caso de psicosis secundarias puede requerirse la intervención de diferentes especialistas, recomendándose que la hospitalización, si fuese necesaria, se realice en un Servicio Médico con el apoyo del Servicio de Psiquiatría de Enlace del centro.

En caso de que aparezca un cuadro de agitación psicomotriz en el contexto de un episodio psicótico se recomienda consultar el capítulo específico sobre este tema en esta misma obra.

IMPORTANTE

- Ante la presencia de síntomas psicóticos es imprescindible descartar un origen somático de los mismos

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Freudenriech O, Brown HE, Holt DJ. Psychosis and schizophrenia. In: Stern TA, Fava M, Wilens TE, Rosenbaum JF, eds. Massachusetts General Hospital Comprehensive Clinical Psychiatry. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016:chap 28.
- 2.- OMS (1992), CIE-10. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento.

Descripción clínicas y pautas para el diagnóstico, Madrid. Ed. Méditor.

CONDUCTA SUICIDA EN URGENCIAS. INTENTO AUTOLÍTICO

Antonio Serrano García

INTRODUCCIÓN

La presencia de ideación o conducta suicida suele ser una de las situaciones más frecuentes en los Servicios de Urgencias de cualquier hospital. Si bien el cuadro que recibimos en Urgencias consiste en un paciente que tiene idea o ha realizado alguna acción encaminada a acabar con su vida, esto constituye el final de un proceso que ha llevado al paciente a esta determinación y es necesario abordarlo desde una perspectiva integradora teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales.

DIAGNÓSTICO

El paciente puede relatar espontáneamente que desea acabar con su vida o puede ser traído al hospital tras la realización de un gesto autolítico, sin embargo, la presencia de suicidabilidad no siempre es evidente y suele ser difícil identificarla. La presencia de quejas somáticas poco específicas en un paciente con factores de riesgo debe hacer sospechar al clínico el riesgo de que aparezca una conducta suicida. Igualmente se debe estar especialmente vigilante ante la posibilidad de conducta suicida en niños y adolescentes.

Entre estos factores de riesgo destacan:

- Varón
- Vive solo
- Abuso de alcohol
- Gestos autolíticos previos
- Problemas económicos o sociales
- Presencia de enfermedad grave o incurable
- Una vez detectada la presencia de suicidabilidad es preciso caracterizarla. Para ello es necesario una exploración detallada que permita comprender el proceso que ha desembocado en la conducta suicida. Es preciso obtener toda la información posible sobre el paciente y su entorno para lograr comprender de la forma más completa el proceso ante el que nos encontramos. Antes de finalizar la exploración debemos ser capaces de responder a las siguientes cuestiones:
 - Desencadenante: ¿Cuál ha sido el motivo último que ha desencadenado la conducta suicida o la decisión de acudir a Urgencias para pedir ayuda?
 - Planificación: ¿El paciente ha planeado meticulosamente su suicidio o la conducta responde a un impulso pasajero?
 - Letalidad: ¿Los medios que el paciente ha utilizado o planea utilizar son probablemente capaces de causar la muerte?
 - Expectativa de rescate: ¿El paciente ha dispuesto la situación de tal manera que es probable que alguien le proporcione ayuda que impida su muerte?
 - Juicio de realidad: ¿El paciente es capaz de tomar decisiones sin que su juicio se vea entorpecido por alguna enfermedad o trastorno?
 - Ganancias: ¿La conducta del paciente es finalista o mediante esta espera modificar alguna situación de su entorno?

La conducta suicida en sí misma no constituye una enfermedad psiquiátrica, sin embargo, es frecuente que aparezca en diferentes trastornos. Principalmente en Trastornos por abuso de sustancias, Trastornos de la personalidad, Trastornos afectivos, Trastorno neuróticos y secundarios a situaciones estresantes (destacando el Trastorno Obsesivo Compulsivo) y en el grupo de los Trastornos Psicóticos.

TRATAMIENTO

Si ha existido ya una conducta suicida inicialmente es preciso controlar los efectos de ésta sobre el organismo. Por ejemplo, si ha existido una sobredosis de fármacos o drogas es preciso proporcionar los cuidados necesarios hasta que la sustancia sea eliminada del organismo. Para ello puede ser necesario administrar algún antídoto que la contrarreste, por ejemplo, flumazenilo para las benzodiacepinas o naloxona para los opiáceos. En casos severos puede requerirse ingreso en UCI.

Independientemente del método mediante el cual el paciente ha tratado de acabar con su vida puede ser necesaria una estancia en observación, no sólo por una cuestión biológica, sino porque el paciente acaba de realizar una acción que puede ser traumática en sí misma y puede ser recomendable que el paciente tenga unas horas para reflexionar sobre su conducta.

Tras haber controlado el cuadro somático y establecido la pausa que se considere necesaria puede ser necesario solicitar la valoración del Servicio de Psiquiatría, que decidirá si es necesaria una hospitalización o el cuadro debe abordarse de forma ambulatoria.

IMPORTANTE

- Ante una conducta suicida lo primero es estabilizar al paciente orgánicamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Miller L. Suicide intervention: basic processes and strategies. Int J Emerg Ment Health. 2011;13(1):37-42.
- Silverman MM, Berman AL. Suicide risk assessment and risk formulation part I: a focus on suicide ideation in assessing suicide risk. Suicide Life Threat Behav. agosto de 2014;44(4):420-31.
- Pelkonen M, Marttunen M. Child and adolescent suicide: epidemiology, risk factors, and approaches to prevention. Paediatr Drugs. 2003;5(4):243-65.

TRASTORNOS AFECTIVOS - TRASTORNO BIPOLAR.

Antonio Serrano García

INTRODUCCIÓN

Los trastornos afectivos corresponden a un grupo de patologías en las que su característica principal consiste en una alteración del estado de ánimo. Debe tenerse en cuenta que una alteración anímica resulta relativamente mantenida en el tiempo e independiente de los factores ambientales y no debe confundirse con las emociones que presentan un carácter pasajero y generalmente son reactivas a un hecho determinado.

DIAGNÓSTICO

Entre las alteraciones del estado de ánimo distinguimos principalmente dos tipos:

- Elevación del estado de ánimo (manía): Consiste en cuadro de euforia o disforia mantenida durante al menos una semana y acompañada generalmente de aceleración del pensamiento, disminución de las necesidades de sueño, gastos excesivos, conducta desinhibida y ocasionalmente síntomas psicóticos que suelen consistir en delirios megalomaníacos o mesiánicos.
- Disminución del estado de ánimo (depresión): Consiste en un cuadro de tristeza patológica mantenida durante al menos dos semanas y que desborda lo esperable ante un hecho ambiental determinado. Generalmente se acompaña de apatía, anhedonia, insomnio o hipersomnia, pérdida de peso. Puede aparecer ideación suicida frecuentemente y ocasionalmente síntomas psicóticos que suelen consistir en ideas de ruina, culpa o hipocondría.

Es relativamente frecuente la presencia de estados mixtos en los cuales se identifican síntomas tanto de manía como depresivos.

A la hora de realizar un diagnóstico de un trastorno afectivo en Urgencias es realizar una anamnesis detallada y longitudinal del paciente identificando los diferentes episodios a lo largo de su vida. También es preciso descartar la presencia de cuadros de alteración del estado de ánimo secundarios a enfermedades o sustancias.

Algunas posibles causas de alteración del estado de ánimo secundaria serían:

- Toma de corticoides (manía corticoidea)
- Hipo o hipertiroidismo
- Lesiones cerebrales (principalmente del hemisferio derecho)
- Isquemia o hemorragia cerebral (depresión vascular o post-ictus)
- Consumo de drogas
- Antidepresivos (manía secundaria)
- Antihipertensivos (depresión)
- Encefalitis

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Una vez detectado el cuadro de alteración del estado de ánimo, caracterizado este y descartada la presencia de una alteración anímica secundaria es preciso planificar el tratamiento.

La presencia de un cuadro maníaco requiere generalmente la supervisión continua del paciente hasta que pueda ser valorado por un especialista en Psiquiatría.

En caso de un episodio depresivo es preciso valorar la presencia de ideación autolítica (ver capítulo correspondiente en esta misma obra) y, si no se evidencia su presencia, valorar un abordaje ambulatorio. Puede ser necesario el concurso de un especialista en Psiquiatría.

En caso de alteración afectiva secundaria es probable que deban participar en el tratamiento varios especialistas y, en caso de ser necesaria la hospitalización, se recomienda que esta se realice en un servicio médico con apoyo del Psiquiatra de Enlace del hospital.

El tratamiento farmacológico para un cuadro depresivo generalmente se realiza con antidepresivos y el de un cuadro maníaco se suele realizar con antipsicóticos y/o eutimizantes. En todo caso no se recomienda iniciar el tratamiento de este tipo de cuadros en Urgencias puesto que en ambos casos van a requerir un seguimiento y una planificación a largo plazo que deberá realizar el facultativo que vaya a ser responsable de su evolución longitudinal.

IMPORTANTE

- El tratamiento de un trastorno afectivo debe considerarse a largo plazo. No se recomienda su inicio en el Servicio de Urgencias

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- OMS (1992), CIE-10. Décima revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripción clínicas y pautas para el diagnóstico, Madrid. Ed. Méditor.
- 2.- Malhi GS, Outhred T, Hamilton A, Boyce PM, Bryant R, Fitzgerald PB, et al. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders: major depression summary. Med J Aust. 5 de marzo de 2018;208(4):175-80.

DEPRESIÓN POSTPARTO

Cristina Forcelledo, Carmen Manso

INTRODUCCIÓN

La depresión postparto se entiende por la sintomatología depresiva mayor que se inicia en un período que no supera el año tras el día de dar a luz. Su frecuencia de presentación en un servicio de urgencias no es alta, pero su detección tiene gran importancia. No sólo por las implicaciones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas, sino también por los factores relacionados con el abordaje tanto de la paciente afectada como del bebé y los apoyos familiares. Por tanto, cabe ser muy cuidadosos en su manejo.

La prevalencia del trastorno varía en porcentaje dependiendo del tipo de estudio y población, existiendo una consistencia de datos de entre 9 a 16% de la población general femenina.

Se estima que el debut de la clínica sucede en el período prenatal en aproximadamente un 50% de las pacientes. En la otra mitad, aquellas que comienzan a presentar síntomas en el postparto, el riesgo es notablemente mayor en los primeros 4-5 meses tras el nacimiento del bebé, disminuyendo en el período posterior.

La existencia de episodios previos de depresión mayor, ligados o no al embarazo o puerperio, duplican el riesgo de depresión postparto. Otros factores de riesgo frecuentemente asociados son los eventos estresores en el período del embarazo, y la escasez de apoyos sociales y económicos tras el parto. Existen otros muchos factores mencionados en la literatura como posiblemente relacionados con la presentación, pero con escasa consistencia (síntomas de ansiedad, neuroticismo elevado, multiparidad, embarazo no deseado, dificultades para la lactancia, patología somática concomitante, historia de abusos...).

Entre las posibles consecuencias del cuadro, se encuentra la claudicación o incompreensión del contexto de apoyo de la paciente, y la negligencia de cuidados del bebé, relacionándose con una mayor probabilidad de alteraciones en su desarrollo psíquico. Hay pocos estudios sobre tentativas autolíticas, suicidio consumado e infanticidio en el contexto de esta patología, pero los datos sugieren un riesgo menor al de la población afectada de un episodio depresivo mayor no relacionado con el puerperio.

El origen de la depresión postparto es desconocido. Se entiende que el mecanismo no difiere mucho de los comunes a la patología depresiva general, si bien pueden verse implicados los factores hormonales que conlleva el proceso evolutivo del embarazo y el parto, así como una susceptibilidad genética de base.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en base a los manuales actuales de los que disponemos es poco concreto en esta entidad clínica. El DSM-5 añade un especificador al episodio depresivo mayor llamado "con debut en el periparto", si bien solo permite su inclusión a aquellos síntomas que se inician dentro del mes posterior al parto, y los síntomas deben durar al menos 2 semanas. Esto no se corresponde con el consenso clínico universal sobre el trastorno, que fija hasta en un año dicho período.

La presentación de una depresión postparto en un servicio de urgencias suele seguir, efectivamente, las manifestaciones clínicas de un episodio depresivo mayor. La iniciativa de acudir para una exploración puede venir tanto de la paciente como de su contexto de apoyo, dentro de una observación subjetiva o comportamientos anómalos, incluyendo un intento auto o heterolesivo. Por las implicaciones que conlleva, es muy importante hacer una evaluación detallada que detecte síntomas de posible riesgo. Dentro de la anamnesis, deberemos explorar:

- Antecedentes personales somáticos. Historia del embarazo actual y previos, si procede.
- Antecedentes personales y familiares de salud mental, especialmente afectivos y psicóticos. Historia de episodios de riesgo autolítico.
- Consumo de tóxicos: alcohol, tabaco y otros (cannabis, cocaína...).
- Contexto social, familiar y apoyos actuales.
- Estresores ambientales.
- Exploración psicopatológica propia de la clínica depresiva mayor:
- Facies triste, contacto retraído y distante, inquietud o inhibición psicomotriz, alteraciones en la comunicación (discurso parco, hipoprosodia, elevada latencia de respuestas).
- Hipotimia mantenida, labilidad emocional o alexitimia, apatía, anergia, anhedonia. Estos síntomas pueden centrarse en el bebé: desinterés y negligencia de sus cuidados, irritabilidad excesiva o escasa respuesta emocional hacia conductas propias del lactante.
- Desorden del ritmo instinto-vegetativo (hiporexia con o sin pérdida ponderal cuantificada, insomnio o hipersomnia).
- Dificultad para la concentración y la toma de decisiones.
- Cogniciones y rumiaciones centradas en la desesperanza, la melancolía, la ruina o la culpa.
- Alteraciones sensorio-perceptivas sugerentes de clínica psicótica activa.
- Cogniciones tanáticas y autolíticas/heterolíticas, distanciamiento y egosintonismo con las mismas, planificación de un acto suicida y acceso a medios.
- Conciencia de enfermedad y juicio de realidad.

El diagnóstico se hará en base a los criterios dispuestos para un episodio depresivo mayor según el DSM-5 requiriendo un mínimo de 3 de ellos. Si bien la exploración no difiere mucho con la propia de la clínica afectiva, es esencial hacer hincapié en los aspectos específicos del cuadro que nos ocupa. Es pertinente realizar la entrevista a solas, dejando al bebé con los acompañantes de la paciente, no sin antes observar la interacción que tiene con el infante. Podemos encontrarnos con que las pacientes se muestran reticentes a dar información, por la percepción social de que deberían ser felices en el momento biográfico en que se encuentran.

La detección de un posible riesgo auto o heterolesivo debe ser la primera prioridad del psiquiatra en urgencias. Se debe preguntar de forma explícita por cogniciones y emociones que lleven a esa dirección. Si bien los datos sugieren un menor riesgo de paso al acto en esta población, nunca se debe pasar por alto y es mandatorio hacer una evaluación exhaustiva. Asimismo, también es fundamental descartar la existencia de una historia de maltrato conyugal en curso. Para ello se debe hacer uso de toda la información recopilada, tanto en la entrevista, como de la paciente y sus familiares, para evaluar la severidad, permitiéndonos abordar el cuadro de la manera más pertinente.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con las siguientes entidades:

- "Baby blues": síntomas depresivos atenuados, leves, que se presentan en los primeros días tras el parto y se resuelven antes de 2 semanas

aproximadamente. Difiere en intensidad, duración y evolución con la depresión postparto, y no precisa tratamiento.

- Episodio depresivo de un trastorno bipolar: realizar una adecuada historia clínica puede ayudar a su distinción, detectando episodios de hipomanía o manía previos. La presencia de una afectividad mixta o una mayor tendencia a la irritabilidad e inquietud o agitación psicomotriz debe hacernos sospecharla.
- Psicosis postparto: síntomas agudos nucleares de escisión yoica (actividad alucinatoria, interpretaciones delirantes...) que conllevan repercusión afectiva y conductual. Es fundamental distinguirla de la depresión postparto por la diferencia de manejo y el mayor riesgo asociado de paso al acto en contexto de pérdida del criterio de realidad.
- Otros cuadros psiquiátricos: no es infrecuente la comorbilidad con trastornos de ansiedad o rasgos desadaptativos de personalidad. Una buena evaluación nos orientará en la dirección más adecuada.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

En caso de que la sintomatología sea leve o moderada, y los acompañantes tengan adecuados recursos para hacer una supervisión estrecha de la paciente y el bebé, se optará por el alta a domicilio, vinculando con los servicios de salud mental que le correspondan. Debe informarse del tratamiento a seguir, los plazos esperados para ver efectos con el mismo, la posible interferencia con la lactancia de los fármacos y los síntomas de alarma por los que, en el caso que precisen, deban volver a consultar en urgencias.

La gravedad de la clínica percibida en urgencias puede llevar al ingreso en la unidad de agudos de psiquiatría de estas pacientes. Por lo general, una vez más, no son criterios unificados y siguen las directrices del episodio depresivo mayor:

- Síntomas afectivos graves, con empeoramiento rápido y progresivo, que no han respondido a tratamiento farmacológico (si tienen).
- Sospecha de riesgo autolítico o heterolítico.
- Pérdida del juicio de realidad.
- Apoyo familiar nulo o claudicado.

El ingreso puede ser voluntario o, en caso de sospechar clínica psicótica o riesgo para la paciente o el bebé, involuntario. Es importante explicar bien a la madre y su familia la situación de justificación médica por la que se opta por esta decisión. Asimismo, en el caso de presentarse una agitación psicomotriz en el servicio de urgencias, no reconducible desde lo verbal, se podrá realizar una contención mecánica bajo el protocolo hospitalario y en presencia del personal de seguridad.

En caso de no existir un apoyo familiar que pueda hacerse cargo del bebé, será necesario comunicar la situación a los servicios sociales para su cuidado mientras la madre permanezca hospitalizada. También habrá que alertar en caso de sospechar un maltrato intradomiliario. Hay que tranquilizar a la paciente sobre este aspecto y focalizar la atención en su recuperación.

Desde el punto de vista farmacológico, es recomendable iniciar alternativas terapéuticas que tengan una baja interferencia con la lactancia, con el fin de favorecer la vinculación madre-hijo. Se planteará como primera línea los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), o bien duales (ISRSN), así como ansiolíticos de duración corta-media para cubrir el período de latencia de inicio de acción. Se muestra aquí una lista de fármacos para uso práctico en la depresión postparto, con baja o nula concentración en leche materna:

- ISRS: Escitalopram, Sertralina, Paroxetina.
- ISRSN: Venlafaxina, Desvenlafaxina, Duloxetina.
- Benzodiacepinas: Lorazepam.
- Otros: Trazodona para el insomnio.

ALERTA: LO QUE NO SE DEBE PASAR EN URGENCIAS SOBRE LA DEPRESIÓN POSTPARTO

- En la depresión postparto, la detección de un posible riesgo para la paciente o el bebé será la primera prioridad.
- Hay que cotejar la información de una entrevista exhaustiva con la aportada por el contexto de apoyo.
- Nos deben alarmar las ideas auto o heterolesivas, las cogniciones de rumiación, desesperanza, ruina y culpa, la negligencia o desinterés de cuidados en el niño y la presencia de sintomatología psicótica.
- Se cursará ingreso en planta cuando los síntomas sean graves y/o no exista un adecuado apoyo familiar. Se alertará a servicios sociales en caso de que el bebé no tenga este apoyo.
- El tratamiento será, preferiblemente, con fármacos que estén a baja concentración en leche materna, para favorecer el vínculo materno-filial.

BIBLIOGRAFÍA

- Guille C, Newman R, Fryml LD, Lifton CK. Management of postpartum depression. J Midwifery Womens Health. 2013 Nov-Dec;58(6):643-53.
- Cuomo I, Maina G, Neal SM, De Montis G et al. Using Sertraline in Postpartum and Breastfeeding: Balancing Risks and Benefits, Expert Opinion on Drug Safety, (2018).
- Meltzer-Brody S, Howard Louise M, Bergink V et al. Postpartum psychiatric disorders. Nature Reviews Disease Primers 4, Article number:18022 (2018). PMID: 29695824.
- Ukatu N, Clare CA, Brulja M. Postpartum Depression Screening Tools: A Review. Psychosomatics 2018 May – Jun;59(3):211-219.
- Molyneaux E, Telesia LA, Henshaw C, Broath E, Bradley E, Howard LM. Antidepressants for preventing postnatal depression. Cochrane Database Syst Rev 2018 Apr 18;4.
- Smith B, Dubovsky SL. Pharmacotherapy of mood disorders and psychosis in pre- and postnatal women. Expert Opin Pharmacother 2017 Nov;18(16):1703-1719.
- Ghaedrahmati M, Kazemil A, Kheirabadi G, Ebrahimi A, Bahrami M. Postpartum depression risk factors: A narrative review. J Educ Health Promot 2017 Aug 9;6:60.
- Latendresse G, Elmore C, Deneris A. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors as First-Line Antidepressant Therapy for Perinatal Depression. J Midwifery Womens Health 2017 May;62(3):317-328.
- Orsolini L, Valchera A, Vecchiotti R, Tomasetti C, Iasevoli F. Suicide during Perinatal Period: Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Correlates. Front Psychiatry 2016. Aug 12;7:138.
- Norhayati MN, Hazlina NH, Asrenee AR, Emilin WM. Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: a literature review. J Affect Disord. 2015 Apr 1;175:34-52.
- O'Hara MW, Wisner KL. Perinatal mental illness; definition, description and aetiology. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014 Jan;28(1):3.12.

- Howard MM, Mehta ND, Powrie R. Peripartum depression: Early recognition improves outcome. Cleve Clin J Med. 2017 May;84(5):388-396.

SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y TRASTORNOS RELACIONADOS. TRASTORNO SOMATOMORFO. HIPOCONDRIASIS. TRASTORNO DE SOMATIZACIÓN. TRASTORNO PSICOSOMÁTICO DEL DOLOR

Forcelledo Cristina, Manso Carmen

INTRODUCCIÓN

El término “somatización” engloba una serie de entidades que tienen por punto en común la queja somática que no se explica de un modo congruente con una enfermedad médica determinada. Estos pacientes acuden a urgencias con mucha frecuencia, demandando exploraciones y diferentes pruebas que justifiquen de algún modo su dolencia, provocando en muchos casos una reacción de contratransferencia negativa y, en definitiva, una frustración que es compartida entre el médico y el propio paciente.

Se estima la prevalencia de estas patologías entre un 17-50% dependiendo de los estudios consultados y las características sociodemográficas que se tengan en cuenta, hablando de una elevada frecuencia de presentación en menor o mayor grado. Se encuentra una correlación positiva con el sexo femenino, y un mayor riesgo en situaciones de bajo nivel socioeconómico, así como la pertenencia a minorías étnicas. Los niños que han presenciado la somatización en su ámbito familiar pueden mimetizar el modelo, y la dificultad para expresar verbalmente las emociones ha sido relacionada con un mayor riesgo de reflejo en la corporalidad.

Se considera controvertido el atribuir la etiología de estas patologías a una causa puramente psiquiátrica, sugiriéndose que podría tratarse de un síndrome multisintomático que complica la presentación de una enfermedad médica.

Cabe resaltar que, a raíz de la publicación del reciente manual DSM-V, la terminología ha variado y en el momento actual se les denomina “síntomas somáticos y trastornos relacionados”. Este epígrafe engloba las siguientes entidades:

- Trastorno de síntomas somáticos, que aúna los antes llamados “trastorno somatomorfo”, “trastorno de somatización” y “trastorno psicosomático del dolor”.
- Trastorno de ansiedad por enfermedad, conocido como “hipocondriasis”.
- Trastorno de conversión
- Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas
- Trastorno facticio.

Salvo el trastorno de conversión, que se tratará aparte, abordaremos en este capítulo cómo diagnosticar y manejar este tipo de casos en el servicio de urgencias hospitalarias.

DIAGNÓSTICO

Trastorno de síntomas somáticos.

Los criterios DSM-V exigidos para el diagnóstico de esta entidad son los siguientes:

- Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria.
- Pensamientos, sentimientos o comportamiento excesivos, relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud.
- Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el trastorno sintomático es persistente (generalmente, durante más de 6 meses).
- La preocupación no se explica mejor por otra patología médica u otro trastorno mental.

Cabe recordar que la queja somática en cuestión es real, no fingida. Las repercusiones afectiva y comportamental llamativas son las que deben poner en alerta sobre la presencia de esta entidad. La constelación sintomática que aqueja al paciente puede ser de lo más variada y, en muchos casos, inespecífica. Los que se dan de forma más frecuente son el dolor (cefaleas, artralgias, abdominalgias, disuria...), los gastrointestinales (gases, náuseas, vómitos, diarrea...), cardiopulmonares (dolor torácico, mareos, disnea, palpitaciones...), neurológicos (quejas mnésicas, síncope, debilidad muscular...) y sexuales (anorgasmia, dismenorrea, dispareunia...).

Una vez establecido el rol de enfermo, pueden llegar a una limitación funcional severa que requiera incluso el cuidado por parte de terceras personas. El diagnóstico de esta entidad constituye una tarea delicada, puesto que por lo general se muestran reticentes a considerar una atribución psicológica, aunque sea parcial, de su malestar. Suelen ser pacientes conocidos en los servicios de urgencias por las múltiples consultas que demandan, bien sea por un mismo síntoma o bien por quejas cambiantes. Por lo general, son los médicos de urgencias y de cabecera quienes conocen ampliamente a estos sujetos, siendo imprescindible descartar previamente una patología somática que justifique los síntomas, así como un manejo razonable de los recursos que solicitan.

Trastorno de ansiedad por enfermedad.

Antes denominada “hipocondriasis”, se cambió su título en el DSM-V por el significado peyorativo de uso popular que arrastraba el término. Los criterios exigidos por el DSM-V para su diagnóstico son los siguientes:

- Preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave.
- No existen síntomas somáticos o, si están presentes, son leves. Si existe otra afección médica o un riesgo elevado de presentarla, la preocupación es claramente desproporcionada.
- Grado elevado de ansiedad acerca de la salud; el individuo se alarma con facilidad por su estado de salud.
- Comportamientos excesivos relacionados con la salud, o evitación por mala adaptación.
- La preocupación está presente al menos 6 meses, pero la enfermedad específica temida puede variar en ese período de tiempo.
- La preocupación no se explica mejor por otro trastorno mental.

Nuevamente hablamos de pacientes que frecuentan los servicios de urgencias demandando pruebas y exploraciones que apacigüen su malestar, aunque generalmente lo hacen de forma temporal. Los pacientes suelen exponer un temor desproporcionado y escasamente fundado por padecer enfermedades tales como el cáncer o distintas ETS (sífilis, SIDA...) sin llegar a un carácter delirante.

La presencia de patologías de este tipo en personas cercanas al paciente (pareja, padres, hermanos, amigos...) puede disparar las cogniciones, y las conductas tienden a tener un carácter desadaptativo evidente: rituales del espectro obsesivo-compulsivo, aislamiento domiciliario, disminución de actividades... Es importante realizar una detallada historia clínica que nos oriente a las posibles causas y repercusiones individuales del malestar, y realizar un diagnóstico diferencial con entidades afectivas o rasgos de personalidad disfuncionales comórbidos. Se otorgará el diagnóstico de “trastorno

de ansiedad por enfermedad” cuando el síntoma príncipes es el de la preocupación reiterativa por contraer o padecer una enfermedad grave.

Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas (FPIOAM)

A continuación, se exponen los criterios DSM-V para el diagnóstico de esta condición:

- Un síntoma o afección médica general está presente.
- Los factores psicológicos o conductuales afectan negativamente a la condición médica en una o más de las siguientes maneras: plantean riesgos adicionales para la salud del paciente, agravan la fisiopatología subyacente de la patología (desencadenan o agravan los síntomas), afectan el curso de la condición médica, interrumpen el tratamiento de la enfermedad.
- Otros trastornos mentales no explican mejor los factores psicológicos o de comportamiento.

Hablamos en este caso de pacientes que pueden acudir al servicio de urgencias con una entidad médica diagnosticada, pero que la evolución es tórpida debido a conductas desadaptativas del afectado. Entre estos factores podemos encontrar mecanismos de afrontamiento patológicos, como la regresión o la negación, por ejemplo. No es la entidad más frecuente por la que se avise al profesional de psiquiatría de urgencias, y su presentación sin comorbilidad afectiva añadida (depresión, trastorno de pánico, duelo...) es rara. Su diagnóstico es delicado y debe realizarse una historia clínica detallada.

Trastorno facticio

Los criterios diagnósticos requeridos por el DSM-V para su diagnóstico son los siguientes:

- Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o la inducción de la lesión o enfermedad, asociada con el engaño identificado.
- El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado.
- El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de recompensas externas obvias.
- El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico.

La clave de esta entidad que la distingue de la simulación, principal reto de diagnóstico diferencial, es la ausencia de un beneficio secundario evidente: ganancia económica, evitar un proceso criminal, evitar obligaciones... El beneficio es fundamentalmente primario, en la apropiación de rol de enfermo, y suele coexistir con rasgos desadaptativos de personalidad o procesos afectivos.

Estos pacientes se presentan en los servicios de urgencias con una actitud generalmente demandante, querulante, resaltando su posición como enfermo. Suelen tener algunos conocimientos médicos que exponen de forma activa, y los síntomas presentados pueden ser problemas de cicatrización de heridas, infecciones, sangrados, laceraciones o problemas gastrointestinales.

Para el diagnóstico se requiere la identificación objetiva de los comportamientos de falsificación de enfermedad y cabe explorar los posibles motivos subyacentes de la consulta en cuestión. Para ello es importante entrevistar a los acompañantes del paciente con el fin de recabar el máximo de información posible.

TRATAMIENTO

La detección y abordaje de este grupo de pacientes en urgencias supone un verdadero reto para el profesional médico. La actitud general va encaminada al rechazo por parte del usuario de aceptar que una condición psicológica pueda ser la responsable de su dolencia. No obstante, se solicitarán las pruebas médicas que se consideren oportunas en cada caso, antes de informar al personal de psiquiatría sobre el cuadro que se presente. Es importante resaltar que no se debe caer en una yatrogenia, realizando exploraciones o tratamientos que no sean estrictamente necesarios, y explicar al paciente con actitud serena y empática la sospecha etiológica.

En cuanto al abordaje por el psiquiatra de urgencias, se debe optar por la combinación entre la farmacología y la intervención en crisis psicoterapéutica.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

- **BENZODIACEPINAS:** preferiblemente de vida media larga, como diazepam o clorazepato dipotásico, para el tratamiento agudo de sintomatología relacionada con la ansiedad. No se debe olvidar que su uso debe ser restringido y en ningún caso sustituible por una psicoeducación sobre el trastorno.
- **ANTIDEPRESIVOS:** se deben iniciar o ajustar sobre el tratamiento ya prescrito, en caso de sospechar patología somatomorfa con comorbilidad afectiva. Optaremos por los de perfil serotoninérgico (sertralina, escitalopram...) en primera instancia, considerando en caso de refractariedad el paso a duales (duloxetina, veblofaxina, desvenlafaxina). Estos últimos tienen además la ventaja, en algunos casos, de poseer un cierto efecto antiálgico (especialmente, la duloxetina). Es importante revisar la patología somática comórbida a fin de detectar posibles contraindicaciones para el uso de estos fármacos.
- **ANTICOMICIALES:** fármacos como la carbamacepina, gabapentina y pregabalina deben considerarse como coadyuvantes sintomatológicos, especialmente en casos refractarios, dado su perfil contra el dolor neuropático y la reducción de ansiedad.

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA EN URGENCIAS

Resulta fundamental informar tanto al paciente como a sus familiares de la sospecha etiológica y de la necesidad de un seguimiento por parte de los servicios de salud mental comunitarios. Se debe explicar de forma respetuosa la sintomatología y en ningún caso invalidar la respuesta emocional que pueda suponer en el paciente esta noticia. No olvidemos que lo habitual será una actitud resistente y que la intervención que se haga determinará en buena parte la vinculación del paciente a los servicios comunitarios. Lo primordial será tranquilizar sobre síntomas menores y repasar aquellos que puedan ser tributarios de una nueva exploración de urgencia.

Dentro de lo posible, es recomendable dar al paciente herramientas de gestión de la ansiedad para mejorar la adherencia a sus dispositivos de referencia y empoderarlo en el proceso de recuperación. Sus acompañantes también deben ser conocedores de las mismas, haciéndolos partícipes de la intervención.

A nivel comunitario, se procederá al abordaje disponible que mejor se adecúe al paciente en concreto. La terapia cognitivo-conductual es la que tiene un mayor número de estudios de eficacia para estas entidades, si bien la psicoeducación, la terapia familiar y la psicoterapia psicodinámica han sido utilizadas con buenos resultados. Las terapias de tercera generación (mindfulness, aceptación y compromiso, compasión...) están en auge en el momento actual con numerosos estudios que avalan su eficacia. Todas ellas pueden administrarse en formato grupal.

ALERTA: LO QUE NO SE DEBE PASAR EN URGENCIAS

- Los síntomas somáticos y trastornos relacionados son un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias. Se debe realizar una exploración somática cuidadosa y sin caer en pruebas innecesarias.
- Por lo general, los pacientes se muestran reticentes a la perspectiva de padecer una dolencia mental, y el manejo supone un reto profesional.
- Es fundamental explicar y tranquilizar de forma respetuosa y empática sobre la sintomatología, a fin de vincular al paciente a los servicios de salud mental comunitarios.
- No debe omitirse la posibilidad de una comorbilidad afectiva, que se debe explorar con detenimiento.
- El tratamiento incluirá las benzodiacepinas en momentos de crisis, el inicio de antidepresivos serotoninérgicos o duales, y considerar como coadyuvantes fármacos anticonvulsivos.

BIBLIOGRAFÍA

- American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5). American Psychiatric Association: Arlington;2013.
- Barsky AJ, Ettner SL, Horsky J, Bates DW. Resource utilization of patients with hypochondriacal health anxiety and somatization. Med Care 2001; 39:705-15.
- Gelauff J, Stone J, Edwards M, Carson A. The prognosis of functional (psychogenic) motor symptoms: a systematic review. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014; 85:220-6.
- Hellman CJ, Budd M, Borysenko J et al. A study of the effectiveness of two group behavioral medicine interventions for patients with psychosomatic complaints. Behav Med 1990; 16:165-73.
- Fehnel CR, Brewer EJ. Munchausen's syndrome with 20-year follow up. Am J Psychiatry 2006; 163:547.
- Henningsen P, Zipfel S, Herzog W. Management of functional somatic syndromes. Lancet 2007; 369:946-55.
- Greeven A, van Balkom AJ, Visser S et al. Cognitive behavior therapy and paroxetine in the treatment of hypochondriasis: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry 2007; 164:91-9.
- Guía de buena práctica clínica en atención primaria de ansiedad y depresión y síntomas somáticos (online).

URGENCIAS EN PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Carmen Manso, Cristina Forcelledo

La atención al paciente infanto-juvenil con carácter de urgencias se ha convertido en los últimos años en una práctica psiquiátrica cada vez más frecuente.

Los motivos para acudir a la urgencia son muy variados, desde crisis de violencia y agresividad, cuadros psicóticos, consumo de sustancias, crisis de ansiedad, intentos de suicidio, hasta problemas familiares, trastornos de conducta, actos delictivos...

El primer objetivo de la urgencia es garantizar la seguridad del paciente, después hacer una rápida evaluación de los motivos de consulta y el cuadro clínico, poner en marcha las medidas terapéuticas inmediatas, pedir exploraciones complementarias si precisan, emitir un diagnóstico y decidir si es necesario un ingreso o no y establecer un tratamiento y hacia donde derivarlo al alta.

Todo esto basado en la historia clínica, información de los padres o cuidadores, informes previos, y otras fuentes de información.

Epidemiología: alrededor de un 5% de las urgencias pediátricas se corresponden con urgencias psiquiátricas infanto-juveniles. Los menores que más frecuentemente consultan son adolescentes (entre 11-15 años) y con ligero predominio en el sexo femenino (52%); los motivos de consulta más frecuentes son: Trastorno de Conducta (37%); Trastorno de Ansiedad Generalizada (21%) e ideación autolítica (13%).

EVALUACIÓN CLÍNICA EN PSIQUIATRÍA INFANTIL:

Lo primero que debemos intentar es establecer una buena relación terapéutica. El derecho a la confidencialidad en adolescentes existe y debemos establecer este marco legal y de confianza al inicio de la entrevista puesto que resulta de vital importancia y es percibida como la base de la confianza.

Debemos intentar una alianza terapéutica con todos los implicados (paciente, familiares, colegio...) y es necesario entrevistar al joven solo y a continuación a los familiares.

- **MOTIVO DE CONSULTA:** imprescindible. Conviene hablar por separado con el menor y los padres/cuidadores y establecer contacto telefónico si hace falta. Si el paciente acude sin sus padres conviene llamarlos lo antes posible.
- **ANTECEDENTES PERSONALES:** tanto somáticos como psiquiátricos/psicológicos. Tratamientos previos y actuales.
- **PSICODESARROLLO:** un breve resumen de los principales hitos del desarrollo: embarazo y parto, desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje; nivel de lenguaje actual, control de esfínteres, alteraciones del movimiento, así como nivel de estudios, rendimiento escolar y comportamiento en el mismo. Importante recoger el nivel de funcionamiento previo y actual.
- **HISTORIA FAMILIAR:** con quien vive, relaciones familiares, tipo de convivencia, así como antecedentes familiares relevantes (somáticos y psiquiátricos).
- **ENFERMEDAD ACTUAL Y FACTOR DESENCADENANTE:** debemos identificar los síntomas principales y además aquellos que acarrear mayor sufrir más al menor y aquellos otros que perturban la convivencia. Estos síntomas serán las dianas de intervención.
- **EXPLORACIÓN FÍSICA** para descartar otros procesos patológicos.
- **EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA:** debe de ser completa siempre que se pueda; otras veces por las circunstancias, estará focalizada en los síntomas, pero siempre debemos incluir signos de ansiedad, ideación auto/heterolítica, alteraciones de la esfera psicótica y orientación.
 - Apariencia y aspecto físico.
 - Relaciones con el entrevistador y el entorno.
 - Orientación.
 - Estado atencional.
 - Impulsividad y tolerancia a la frustración.
 - Humor y afectividad.
 - Signos de ansiedad psíquica y física.
 - Auto/heteroagresividad.
 - Alteración del curso/contenido del pensamiento.
 - Lenguaje y alteraciones del discurso.
 - Alteraciones sensorio-perceptivas.
 - Psicomotricidad.
 - Rasgos de personalidad.
 - Capacidad de juicio y planes de futuro.
 - Sueño y apetito.
- **EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:** analítica completa, tóxicos, ECG, EEG (si se sospecha epilepsia), técnicas de imagen, sobre todo si no existen antecedentes personales psiquiátricos.
- **DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:** suelen ser diagnósticos longitudinales, por lo que muchas veces no es posible realizarlo en una situación de urgencias. Aquí el diagnóstico tendrá valor orientativo o preliminar y haremos énfasis en el cuadro clínico del paciente en ese momento y en los síntomas más graves.
- **PLAN TERAPÉUTICO:** lo primero que debemos hacer es tranquilizar al paciente y a la familia y establecer las medidas de seguridad en caso de riesgo de actos violentos, agitación, peligro de huida o intentos de suicidio. Finalmente estableceremos un tratamiento farmacológico para determinados síntomas como ansiedad, agresividad o agitación.
- Como estrategia final y para evitar la angustia familiar o vuelta al servicio de urgencias debemos informar claramente del diagnóstico y pautas de manejo en domicilio.

No debemos olvidar que los niños y adolescentes son seres en desarrollo siendo extremadamente influenciados del ambiente que les rodea.

Así se recomienda no solo un enfoque clínico (factores biológicos, psicológicos y sociales del paciente) sino también el sistema familiar que le rodea y de su entorno social y comunitario.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

El objetivo principal es la seguridad y proteger tanto al paciente como a terceros, por lo que la evaluación y el manejo del riesgo asociado a la clínica

psiquiátrica es un componente esencial en nuestra actuación en urgencias.

Las áreas de exploración son:

- Vulnerabilidad: exposición a experiencias peligrosas a través de factores personales o ambientales.
- Conductas o ideas suicidas.
- Inestabilidad psicopatológica.
- Agresión a terceros.

En la atención en urgencias se debe implicar a la familia tanto en la recogida de información como a la hora de elaborar un plan de seguridad para predecir nuevos actos de riesgo.

A continuación, se explicarán los principales cuadros que podemos encontrar en el servicio de urgencias psiquiátricas en edad infanto-juvenil: paciente agitado; intentos/ideas de suicidio y trastorno de ansiedad.

PACIENTE AGITADO

Numerosos trastornos psiquiátricos, circunstancias y enfermedades pueden motivar la agitación de un menor:

- Trastornos con impulsividad: **trastorno negativista desafiante**, TDAH, **trastorno de conducta**, trastorno bipolar, **intentos de suicidio**, rasgos de personalidad intensos.
- **Cuadros psicóticos**: la agitación psicomotriz y agresividad puede darse tanto en la esquizofrenia de inicio temprano como en la adolescencia, pudiendo formar parte de un primer episodio psicótico o como una recaída.

En los adolescentes predominan las paranoias, la ansiedad, la agitación, descontrol, obsesividad e ideación suicida.

En un primer episodio psicótico debe descartarse la organicidad.

- Consumo y dependencia de drogas.
- Trastorno general del desarrollo y retraso mental que favorecen las reacciones agresivas ante situaciones frustrantes, siendo muy frecuentes las agitaciones.
- Los Trastornos del Espectro Autista son muy sensibles a cambios de rutina o ambientes y a enfermedades que sufren y que no se diagnostican debido a su dificultad comunicativa.
- Medio familiar caótico y desorganizado, con violencia, privación y maltrato.
- Trastorno de estrés post-traumático.
- Enfermedades orgánicas y estados patológicos de tipo metabopatías, infecciones, encefalopatías, ingestiones medicamentosas y efectos adversos de fármacos.
- Enfermedades neurológicas (sobre todo epilepsia temporal y crisis parciales), TCE.

Manual de actuación ante un menor agitado:

Actuar con prontitud.

Medidas de protección para el paciente que sean terapéuticas.

Mantener la calma y poner en marcha las medidas de seguridad más urgentes.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN ANTE EL PACIENTE AGITADO

Se deben realizar en medio seguro; con el número suficiente de personas adiestradas.

Los pacientes activamente agitados no responden a intervenciones verbales que pueden incluso aumentar la agitación, por lo que está indicada la contención física y la sedación farmacológica.

Las medidas de intervención se han dividido en:

- Medidas ambientales: sobre todo en los pródromos. Separar al paciente de la causa que ha generado la agresividad (novia, padres, hermanos...); buscar un lugar tranquilo y sin objetos potencialmente peligrosos al alcance del paciente, respetar la privacidad e intimidad del paciente en la medida de lo posible sin asumir riesgos innecesarios.
- Contención verbal: en niños y adolescentes debería ser la primera medida si se puede. Están encaminadas a que el paciente se tranquilice mediante técnicas verbales y de comunicación: iniciar la entrevista por aspectos diferentes a la violencia, buscando incluso temas en común; actitud empática y mostrar interés; no humillar ni hacerle sentir rechazado; ceder a peticiones razonables; procurar una descarga emocional controlada permitiendo que el menor hable de lo que ha ocurrido. Finalmente llegamos a la fase de sugestión induciendo sentimientos de tranquilidad en el paciente ("después de hablarlo te encontrarás más tranquilo"; "tenías que descargar" ...). todo esto solo es posible si el paciente no tiene una actitud hostil o desconfiada hacia nosotros. Finalmente debería haber una fase de clarificación en la que se hiciese un breve resumen afín de ayudarle a separar realidad objetiva del concepto subjetivo distorsionado que tiene de esa realidad.
- Contención física: solo debe usarse cuando sea necesaria para proteger al paciente y otras personas. En este caso antes de hacerla se debería informar a los padres o tutores legales a los que se les dejará fuera.
- Tratamiento farmacológico: la mayoría de las veces tenemos que recurrir a la vía intramuscular, pero en menores hay que ofrecerles medicación oral antes; si la aceptan se recomienda: Risperdal (2-10mg), Olanzapina (entre 2,5-20mg) y ahora empieza a probarse el aripiprazol IM. Sino acepta la vía oral, el fármaco más usado es el haloperidol: dosis en niños a partir de 3 años: 2,5mg IM (1/2 ampolla) y en adolescentes 5mg (1 ampolla).

INTENTOS DE SUICIDIO

Cada vez más frecuentes. El comportamiento suicida aumenta en la adolescencia, sobre todo en las mujeres.

El intento y la ideación suicida surgen la mayoría de las veces en el contexto de problemas y conflictos familiares crónicos (separación, abandono, maltrato...).

El niño se siente solo, desconcertado, sin nadie con quien hablar, triste y deprimido y piensa que la muerte es el único remedio. El intento es siempre el

medio de salir de una situación insoportable y pasar a otra mejor.

Señales de alerta: ánimo deprimido, sentimientos de soledad y desvalimiento, pensamientos y preocupación acerca de la muerte y deseo de morir, los antecedentes personales de depresión y conductas suicidas. El primer factor de riesgo es la existencia de un suicidio consumado en un familiar de primer grado.

Durante nuestra evaluación debemos transmitir seguridad y confianza, dejar clara la gravedad de la conducta y evaluar las características del intento y su potencial lesivo. En el informe clínico debemos recoger los siguientes aspectos:

- Método utilizado.
- Accesibilidad a los agentes utilizados.
- Nivel de planificación (premeditado/impulsivo).
- Intencionalidad (muerte, aliviar malestar, herir a terceros, demanda de ayuda).
- Probabilidad de rescate.
- Notas de suicidio u otros medios de comunicación del acto.
- Perspectiva del joven acerca del potencial de letalidad.
- Crítica del acto.
- Intentos previos.
- Proyección de futuro.

La decisión final de ingresar al paciente dependerá de la letalidad del intento, de la exploración psicopatológica y persistencia de las ideas de suicidio, de la patología psiquiátrica asociada y de la incapacidad de la familia de contención.

BIBLIOGRAFÍA

- San Sebastián J, Quintero FJ. Urgencias en psiquiatría infantojuvenil. En: Chinchilla A, Correas J, Quintero FJ, Vega J, editores. Manual de urgencias psiquiátricas. Barcelona: Masson; 2003. p. 393-400.
- Alda JA, Gabaldón S. Urgencias Psiquiátricas. En: Soutullo C, Mardomingo MJ, Manual de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. 1a ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2010. p. 381-394.
- Basant K. Puri; Ian H. Treasaden; Urgencias de psiquiatría. Serie Manuales. Biblioteca Aula médica.
- M.J. Mardomingo. Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente. Ediciones Díaz de santos; 2015 Capítulo 27 (p 1005-10017); Capítulo 32: Urgencias psiquiátricas de niños y adolescentes (p 1147-1164)
- L. Villalta; Diagnóstico de urgencias y el informe urgente. Módulo urgencia psiquiátrica infantil y del adolescente. Máster propio en psiquiatría infantil y juvenil, Universidad Cardenal Herrera.
- Sthall.

SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO

S. Nuñez Sevillano, F.L. Rodríguez Fernández, I. González Rodríguez, C.M. Franch Pato, R. Gómez Martínez, J. T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El **síndrome neuroléptico maligno** es una de las **escasas urgencias dentro de la patología psiquiátrica**, que amenaza a la vida y está asociado al uso de neurolepticos.

El **cuadro clínico** está basado en:

- **Cambios del estado mental.**
- **Fiebre.**
- **Rigidez.**
- **Disautonomía.**

Se trata de un cuadro poco frecuente, pero, en ocasiones, difícil de diagnosticar debido a la variabilidad en cuanto a su forma de presentación y evolución.

La fisiopatología del cuadro se caracteriza por los efectos de agentes neurolepticos sobre los ganglios de la base, hipotálamo y sistema nervioso simpático. **La hipótesis sobre la fisiopatología está asociada a diversas acciones conocidas de los antipsicóticos** sobre el sistema extrapiramidal e hipotalámico. Parece ser que la causa esta mediada por la disminución de la actividad dopaminérgica en el sistema nervioso central.

La incidencia de este síndrome se estima **entre el 0,02 y el 3% de los pacientes tratados con antipsicóticos**, siendo un cuadro poco frecuente pero potencialmente letal. Se ha descrito este cuadro en todos los grupos de edad, y la edad no se considera un factor de riesgo para el mismo.

La **incidencia es mayor en hombres**, posiblemente explicada por la mayor violencia que presentan los pacientes de este sexo y las dosis de antipsicótico más elevadas que suelen requerir los pacientes. La aparición de la clínica suele acontecer durante la primera semana tras el inicio del tratamiento neuroléptico.

En relación a los fármacos asociados a este síndrome, se han presenciado casos en neurolepticos de máxima potencia (**haloperidol**) como de baja potencia (**clorpromazina**). Los antipsicóticos atípicos también pueden ocasionar esta reacción, que se considera idiosincrática. No es un fenómeno que dependa de dosis, pero las dosis elevadas se consideran factor de riesgo.

Las **situaciones** que provocan síndrome neuroléptico maligno **con mayor frecuencia** son:

- Asociación de neurolepticos con antidepresivos tricíclicos o litio.
- Pacientes con síndromes mentales orgánicos.
- Asociación de varios neurolepticos de forma simultánea.
- Administración de antipsicóticos de liberación retardada y fármacos dopaminérgicos como los antiparkinsonianos.
- El uso de neurolepticos por vía parenteral.

Hasta un 90% de los pacientes que sufren síndrome neuroléptico maligno padecen deshidratación, pudiendo ser esta condición un factor de riesgo o una complicación temprana del cuadro.

DIAGNÓSTICO

La presentación clínica del síndrome neuroléptico maligno se basa en la **presencia de fiebre, rigidez, cambios en el estado mental y disautonomía**.

De forma prodrómica los pacientes pueden presentar ansiedad de difícil manejo, clínica extrapiramidal y alteraciones de la conciencia.

El diagnóstico es clínico aunque las pruebas de laboratorio tienen especial importancia a la hora de evaluar al paciente, ayudan a la confirmación del síndrome y nos permiten monitorizar posibles complicaciones.

Dentro del diagnóstico diferencial debemos descartar las causas infecciosas y las lesiones estructurales, por lo que el TAC o la RMN cerebral, así como la punción lumbar, pueden aportarnos datos relevantes. Se han reportado casos de elevaciones inespecíficas de proteínas en LCR hasta en un tercio de los casos de síndrome neuroléptico maligno.

No podemos olvidar dentro del diagnóstico diferencial el síndrome serotoninérgico, comentado en otro capítulo. A diferencia del síndrome neuroléptico maligno, en el síndrome serotoninérgico podemos presenciar más frecuentemente ataxia, temblor, hiperreflexia o mioclonías. Los vómitos y la diarrea también son más frecuentes en el síndrome serotoninérgico, mientras que es menos probable encontrar la rigidez y la hipertermia que caracterizan al síndrome neuroléptico maligno.

Los criterios diagnósticos para el síndrome neuroléptico maligno varían según distintos autores, pero el consenso internacional, formado por un conjunto de profesionales de distintas especialidades, se basa en los siguientes hallazgos clínicos y de laboratorio:

Criterios diagnósticos	Puntuación
• Exposición a antagonista dopaminérgico o suspensión de agonista de la dopamina en las últimas 72 horas.	• 20
• Hipertermia (>38° en dos ocasiones por medición oral).	• 18
• Rigidez	• 17
• Nivel de conciencia disminuido o fluctuante.	• 13
• Elevación de la CK al menos cuatro veces por encima de los valores normales.	• 10
• Labilidad del sistema nervioso simpático definida por al menos dos de las siguientes: - Elevación de la tensión arterial (sistólica o diastólica >25% del valor basal). - Fluctuación de la tensión arterial (cambios diastólicos de >20mmHg o sistólicos de >25mmHg en 24h). - Diaforesis. - Incontinencia urinaria.	• 10

Criterios diagnósticos	Puntuación
Hipermetabolismo definido como aumento de la frecuencia cardíaca (>25% del valor basal) y aumento de la frecuencia respiratoria (>50% del valor basal).	5
Estudios que descarten causa infecciosa, tóxica, metabólica o neurológica.	7

El consenso no estipula una puntuación mínima para la confirmación del síndrome, pero permite valorar cada criterio de forma independiente y nos marca la importancia de cada uno de los mismos.

Como referencia, los criterios más extendidos en la práctica clínica son los descritos por Levenson, de los cuales el paciente debe cumplir los tres mayores o dos mayores y cuatro de los menores:

Criterios de Levenson

Criterios mayores	Criterios menores
- Fiebre. - Rigidez muscular. - Elevación de la CPK.	- Taquicardia. - Alteraciones en la tensión arterial. - Taquipnea. - Alteración del nivel de conciencia. - Diaforesis. - Leucocitosis.

TRATAMIENTO

El primer paso en el tratamiento del síndrome neuroléptico maligno es retirar el antipsicótico o los posibles desencadenantes (litio, agentes anticolinérgicos o serotoninérgicos).

Las medidas de soporte van encaminadas a evitar las complicaciones más frecuentes, que pueden ser de vital gravedad:

- Deshidratación.
- Trastornos hidroelectrolíticos.
- Fallo renal.
- Infarto de miocardio.
- Fallo respiratorio por rigidez torácica.
- Tromboflebitis.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Trombosis venosa profunda.
- Convulsiones.
- Fallo hepático.

Para ello es importante mantener al paciente euvolémico, mediante hidratación intensa. De esta manera se reduce el daño renal y se evita la deshidratación provocada por la diaforesis. Se pueden usar mantas de enfriamiento u otras medidas físicas para controlar la temperatura. La tensión arterial será controlada mediante agentes antihipertensivos como la clonidina o el nitroprusiato, que ha demostrado vasodilatación cutánea que podría ayudar al enfriamiento cutáneo. El uso de heparina de bajo peso molecular puede prevenir efectos protrombóticos secundarios al cuadro. Las benzodiacepinas son efectivas tanto en el control de la agitación que puede acompañar el cuadro como en la prevención de crisis convulsivas.

Otros tratamientos han demostrado efectos beneficiosos, aunque la eficacia es, por el momento, incierta y ampliamente discutida:

- Dantrolene:** dosis mínima inicial para adultos y niños: 1mg/kg a pasar en 15 minutos IV. Se puede repetir la dosis cada 10-15 minutos, hasta una dosis máxima acumulada total de 10mg/kg/24h. La reversión de la hipertermia maligna generalmente se consigue con una dosis de 2,5mg/kg. Este relajante de músculo esquelético puede tener utilidad dada su rápida relajación, disminuyendo la rigidez y producción de calor. Debe vigilarse su hepatotoxicidad y suspenderlo tan pronto como sea posible.
- Bromocriptina:** en dosis de 2,5mg por sonda nasogástrica cada 6-8/h este agonista de la dopamina ha demostrado restaurar el tono dopaminérgico de los pacientes. Las recomendaciones dictan mantener el tratamiento unos 10 días y reducirlo lentamente.
- Amantadina:** este fármaco ofrece un efecto dopaminérgico y anticolinérgico. Se presenta como una alternativa a la bromocriptina usado en dosis iniciales de 100 - 200mg vía oral o mediante sonda nasogástrica.

La experiencia parece ser positiva con otros fármacos como la levodopa, apomorfina, carbamazepina o las benzodiacepinas (lorazepam y clonazepam). De forma excepcional, se han descrito casos de mejoría tras terapia electroconvulsiva. En cualquier caso, esta opción debe quedar relegada al fallo del tratamiento farmacológico, dado que no hay estudios aleatorizados que justifiquen esta medida.

A la hora de valorar reintroducir un nuevo antipsicótico, la clozapina parece ser el más afín al receptor dopaminérgico tipo 4, por lo que puede ser una buena opción en pacientes que han sufrido este cuadro.

BIBLIOGRAFÍA

- Antonio M, Argüello M, Lozano Lozada A, César J, Casallas G. Síndrome neuroléptico maligno. Acta Colomb Cuid Intensivo [Internet]. 2016 [cited 2020 Mar 9];16(1):38–46. Available from: www.elsevier.es/acci
- Vázquez Estévez R, Lorena M, Blanco M, José J, Castillo M, Isabel M, et al. Psiquiatría Biológica Neuroleptic malignant syndrome: Difficulties in the differential diagnosis. Psiquiatr Biol [Internet]. 2016 [cited 2020 Mar 9];23(3):122–4. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.psiq.2016.04.003>
- Su YP, Chang CK, Hayes RD, Harrison S, Lee W, Broadbent M, et al. Retrospective chart review on exposure to psychotropic medications associated with neuroleptic malignant syndrome. Acta Psychiatr Scand [Internet]. 2014 Jul 1 [cited 2020 Mar 11];130(1):52–60. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1111/acps.12222>
- Gurrera RJ, Caroff SN, Cohen A, Carroll BT, DeRoos F, Francis A, et al. An international consensus study of neuroleptic malignant syndrome diagnostic criteria using the Delphi method. J Clin Psychiatry [Internet]. 2011 Sep [cited 2020 Mar 11];72(9):1222–8. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21733489>

SÍNDROME SEROTONINÉRGICO

S. Nuñez Sevillano, F.L. Rodríguez Fernández, I. González Rodríguez, R. Gómez Martínez, C.M. Franch Pato, J.T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El síndrome serotoninérgico se basa en una hiperactividad serotoninérgica a nivel del sistema nervioso central y periférico, basado en la aparición de status mental, clínica autonómica y neuromuscular. El aumento del uso de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la polimedicación hacen que se incrementen los casos de este síndrome, especialmente en población de edad avanzada. Por encima de los 65 años, más de un 20% de los pacientes consumen varios fármacos, incrementando así las posibilidades de reacciones adversas, como es el caso del síndrome serotoninérgico.

DIAGNÓSTICO

Este síndrome es el resultado de la sobre-estimulación de los receptores de 5-hidroxi-triptamina 1a (5-HT_{1a}) en los núcleos grises centrales y del bulbo, así como de los receptores 5-HT_{2a}. No se trata de una reacción idiosincrática, sino que se considera una reacción predecible.

Este cuadro suele presentarse de forma aguda, de modo que la clínica suele aparecer en menos de 24 horas desde que se añade un nuevo fármaco serotoninérgico o se aumenta la dosis de alguno ya pautado. La lista de fármacos que interfieren con la síntesis, liberación, inhibición de la recaptación, o del metabolismo de la serotonina es variada, y debemos tener en cuenta los distintos agentes:

Síntesis de 5-HT	Liberación de 5-HT	Inhibición de la recaptación de 5-HT	Inhibición del metabolismo de 5-HT	Estimulación del receptor post-sináptico.
- L-triptófano. 5-hidroxitriptófano.	- Anfetaminas y sus derivados. - Cocaína. - Reserpina. - Tetrabenazina. - Levodopa. - IMAO.	- Todos los ISRS. - Trazodona. - Nefazodona. - Venlafaxina. - Antidepresivos tricíclicos. - Bupropión. - Dextrometorfano. - Tramadol. - Meperidina. - Sibutramina. - Hipérico. - Cocaína. - Anfetaminas y derivados.	- IMAO. - Hipérico. - Omeprazol. - Ácido valproico. - Ketoconazol. - Linezolid. - Ritonavir.	- Buspirona. - Agonistas 5-HT₁. - Litio. - Carbamazepina.

Se debe tener en cuenta que la potenciación mediante el uso de más de un antidepresivo es una práctica habitual en psiquiatría, descrita en guías de práctica clínica. Añadir un segundo antidepresivo de mecanismo de acción distinto genera sinergias con el tratamiento previamente establecido, por lo que esta asociación es una de las estrategias para la optimización del tratamiento.

La presentación clínica de este cuadro es variada y este polimorfismo conlleva a una dificultad diagnóstica que genera incluir este síndrome en cuadros de diagnóstico diferencial. El diagnóstico es clínico y se apoya en la presencia de algún fármaco que lo justifique, siendo éste uno de los principales criterios diagnósticos actuales. A los criterios clásicos descritos por Sternbach, **Radomski revisa y modifica el diagnóstico** de la siguiente forma:

- Aumento de dosis o adición de agente serotoninérgico al tratamiento ya establecido con la presencia de **4 síntomas mayores o 3 mayores y 2 menores**.
- Los síntomas no se corresponden con un trastorno psiquiátrico (o una intensificación de éste) que ya estuviera presente previamente al nuevo tratamiento.
- Excluir causas infecciosas, metabólicas, endocrinológicas o tóxicas.
- No debe haberse introducido un tratamiento antipsicótico, ni aumentadas sus dosis antes de la presencia de los síntomas.

Síntomas mayores y menores

Alteración	Síntomas mayores	Síntomas menores
Status mental	- Confusión. - Coma.	- Hiperactividad. - Agitación. - Insomnio.
Autonómica	- Hipertermia - Diaforesis	- Taquicardia. - Taquipnea. - Disnea. - Hipo/Hipertensión. - Diarrea.
Neuromuscular	- Mioclonos e hipertonía. - Hiperreflexia. - Temblores.	- Incoordinación. - Midriasis. - Acatasia. - Ataxia.

La presencia de un nuevo antipsicótico o el aumento de dosis del mismo debe hacernos sospechar en un síndrome neuroléptico maligno que, dada su gravedad y mortalidad, debe ser descartado de forma prioritaria, como se comentará en otro capítulo.

TRATAMIENTO

La evolución del cuadro puede ser fatal, pero habitualmente el pronóstico es bueno con la retirada del fármaco causante del mismo. El tratamiento tendrá una intensidad acorde a la gravedad del cuadro.

En casos leves se recomienda:

- Retirar el fármaco causante.
- Medidas de soporte.
- Tratamiento basado en benzodiazepinas (loracepam o diacepam)

En casos moderados, con compromiso cardiorrespiratorio o de temperatura, se recomienda:

- Uso de infusiones electrolíticas para mantener una diuresis por encima de 50-100 ml/h para evitar daño renal secundario a mioglobina.
- Los antagonistas 5-HT_{2a} (trazodona o mirtazapina) pueden tener algún beneficio.
- Uso intensivo de benzodiacepinas para controlar las mioclonías, agitación y riesgo de convulsiones.
- No está recomendado el uso de antipiréticos, dado que el aumento de temperatura se debe a una actividad muscular.

Si la hipertermia excede los 41° o la agitación no cede, se deberá valorar la sedación, ventilación mecánica y parálisis neuromuscular.

Sin evidencia en estudios controlados, el uso de ciproheptadina, clorpromazina y ziprasidona parecen ser útiles en el tratamiento del síndrome serotoninérgico dado su bloqueo ante 5-HT.

BIBLIOGRAFÍA

- Ener RA, Meglathery SB, Van Decker WA, Gallagher RM. Serotonin syndrome and other serotonergic disorders [Internet]. Vol. 4, Pain Medicine. 2003 [cited 2020 Mar 11]. p. 63–74. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12873279>
- Hemeryck A, Belpaire F. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors and Cytochrome P-450 Mediated Drug-Drug Interactions: An Update. Curr Drug Metab. 2005 Mar 25;3(1):13–37.
- Boyer EW, Shannon M. Current concepts: The serotonin syndrome [Internet]. Vol. 352, New England Journal of Medicine. 2005 [cited 2020 Mar 11]. p. 1112–20. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15784664>
- Bodner RA, Lynch T, Lewis L, Sternbach H. The Serotonin Syndrome. Vol. 352, Xahn D. Serotonin Syndrome. Neurology. 2005.
- Young P, Finn BC, Álvarez F, Verdaguer MF, Bottaro FJ, Bruetman JE. Síndrome serotoninérgico. Presentación de cuatro casos y revisión de la literatura. An Med Interna [Internet]. 2008 [cited 2020 Mar 9];25(3):125–30. Available from: http://www.salvador.edu.ar/vrid/imaie/manual_fauna1.pdf